

Proyecto Final | Entrega 1

Ingeniería de Software

Atención a Urgencias

Camilo Ruiz López | 1098307006

Juan David Cardozo Torrez | 1094881210

Tomas Castaño | 1090274632



Universidad del Quindío
Ingeniería de Sistemas y Computación
Armenia, Quindío, 2025



Componentes del entregable número uno (1)

Descripción del problema:

- Contexto del negocio
- Problema que se desea resolver
- Actores/Usuarios involucrados
- Importancia de la resolución del problema

Contexto del negocio

- Se plantea una herramienta basada en software tangible que proporcione un servicio de apoyo inmediato a la resolución de emergencias médicas en un contexto hospitalario/ médico que permita a la entidad hospitalaria poder llevar a cabo la resolución de situaciones críticas de manera eficiente y efectiva.

Problema a resolver

- Se busca resolver la problemática de una incorrecta gestión de las urgencias en un centro hospitalario; debido a esto, se ofrece un sistema completo que va a permitir una correcta distribución de la información y una pertinente realización de cada uno de los procesos que conforman la emergencia que tenga algún paciente, principalmente regulando cualquier error que pueda perjudicar y afectar la vida de la persona.

¿Quiénes son los actores o usuarios involucrados?

- Los actores son principalmente secretarios y recepción, quienes manejan el software de toda la gestión, los médicos ya sea de medicina general o especialistas, auxiliares médicos, enfermeros, paciente, ambulancia y demás personal médico capacitado.

¿Por qué es importante resolver este problema?

- Es importante debido a que es un problema que se vive en la vida cotidiana constantemente; pasan miles de accidentes, homicidios y demás casos donde se presenta vulnerabilidad en alguna persona, entonces se requieren estos llamados de emergencias/urgencias. Al ser una situación diaria y de mucha presión, muchas veces se cometen equivocaciones en el proceso; por lo tanto, es necesario resolver esta problemática por medio de análisis y luego un software que permita la gestión pertinente.

*Plantilla de proceso***Modelaje del proceso identificado**

- Actores involucrados
- Pasos del proceso
- Subprocesos
- Flujo general de la actividad

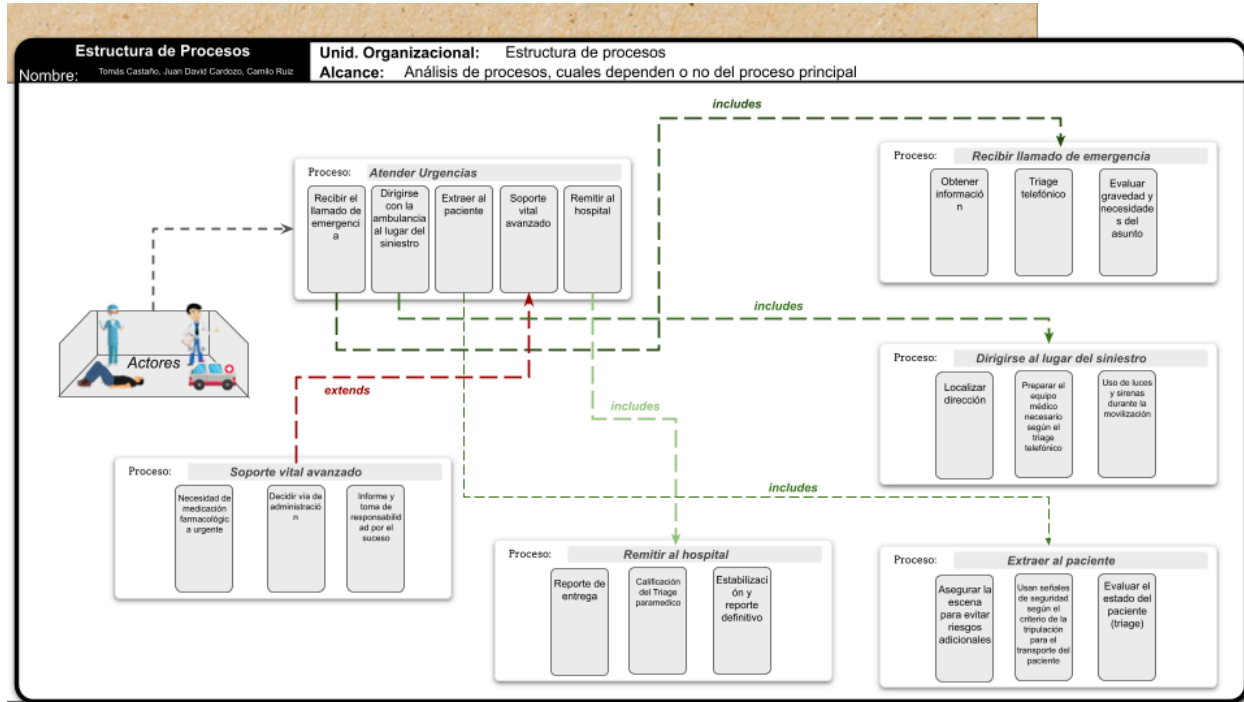
Validación de Transacción		Formulario : Plantilla de procesos
Nombre: Tomás Castaño, Camilo Ruiz, Juan David Cardozo		
Plantilla de procesos • Solicitud de atención • Envío de equipo de emergencia • Atención pertinente al paciente a la hora de llegada al siniestro. • Envío al punto hospitalario más cercano. • Triage. • Trasladar al paciente a la habitación correspondiente. • Revisión del paciente. • Revisión del paciente. • Asigna cita. • Confirmar cita. • Enviar notificación.		

Plantilla de proceso			Proceso: Atención en Urgencias		Finalidad empresa		Satisfacción y salud estable del paciente			
Nombre: Tomás Castaño, Juan David Cardozo, Camilo Ruiz					Finalidad cliente		Ser atendido y recibir tratamiento			
¿Cómo?	¿Quién?		¿Qué?		¿Dónde?		¿Cuándo?	¿Por qué?		
R = responsable. A = Aprobador. C = Consultado. I = Informado.										
¿Actividad?	¿Roles internos?	¿Roles externos?	¿Información relevante?	¿Insumos que necesita?	¿Recursos con que lo hace?	¿Dónde lo hace?	¿Cuándo lo hace?	¿Qué necesita para iniciar?	¿Por qué lo hace?	Punto de control / regla de negocio
Solicitud de atención	Recepción del hospital	Paciente	-Historial medico -Documento de identidad -Causa	Atención Medicinas Transporte	Teléfono	Asincrónica Oficina del hospital	En cualquier momento	Descripción de situación y dirección	Emergencia medica urgente	Que se encuentre localidad cercana
Envío de equipo de emergencia	Enfermeros y auxiliares	Paciente y transeúntes	-Dirección -Estado del paciente	-Botiquin medico -Material primeros auxiliares -Gasolina	Ambulancia y equipo medico	Carretera y lugar del acontecimiento	Después de la solicitud	-Dirección -Verificación equipo y material medico	-Es necesario para atender de manera eficiente la solicitud	-Datos claro y no ambiguos -Equipo medico
Atención pertinente al paciente a la hora de llegada al siniestro	Equipo profesional capacitado para atender	Paciente, testigos	Estado de la persona	Equipo de primeros auxilios	Camilla, Equipo de recogida	Lugar del siniestro	En el momento de llegada al siniestro	Informe de estado actual del paciente	Obtener información con la cual proceder	Informe claro, punto de llegada
Envío al punto hospitalario mas cercano.	Doctor, Enfermeros, Equipo medico	Paciente, Contactos de emergencia	-Estado actual del paciente - Historial Médico	Transporte adecuado, pertinente atención en el camino	Llave del vehiculo, gasolina, suministros medicos	En el camino entre el lugar de los hechos y el punto hospitalario	Después de realizar el debido chequeo del paciente	Transporte, tener al paciente en posición adecuada	Para poder brindarle al paciente la ayuda necesaria	Seguir protocolos de seguridad y reglamento del hospital
Triage	Enfermeros y médicos generales, paciente	Personal técnico y admisiones	Signos vitales, nivel de urgencia	Equipos de medición y elementos de protección personal	Suministros/inventario del hospital	Transporte donde es llevado el paciente	Antes de ingresar al punto hospitalario	Espacio adecuado, protocolo y personal capacitado	Para determinar la gravedad de la urgencia y establecer una correcta gestión	Realizar un flujo de trabajo adecuado
Trasladar al paciente a la habitación correspondiente	Paciente, enfermeros y médicos	Auxiliares y administradores	Estado del paciente, disponibilidad de la habitación	Camilla y personal adecuado	Inventario del hospital y disponibilidad de personal	En el punto hospitalario	Momento de llegada del paciente y registro rápido	Documentación clara del estado del paciente	Proporcionar los recursos necesarios al paciente	Reglamentación del hospital y disponibilidad de los recursos
Revisión del paciente	Paciente, médico adecuado	Enfermero, especialista	Estado del paciente, disponibilidad de medicamentos	Medicación apropiada, sistema de reportes/revisiones	Suministros del hospital e insumos	Habitación designada del paciente	Momento en el que el paciente es posicionado correctamente	Equipamiento clínico, toma de oxigeno y documentación	Para neutralizar los síntomas del paciente o regularlo	Debida revisión con el personal pertinente, planeación adecuada
Asigna cita	Personal administrativo	Paciente	Disponibilidad de agenda, prioridad del paciente	Sistema de agenda, historial del paciente	Sistema informático	Oficina de admisiones	Después de la revisión médica	Organizar la atención	Garantizar continuidad del tratamiento	Agenda disponible y validada
Confirma cita	Personal administrativo	Paciente	Fecha, hora y lugar de la cita	Sistema de citas, datos de contacto	Teléfono / sistema informático	Oficina del hospital	Posterior a la asignación de la cita	Evitar inasistencias	Asegurar que el paciente esté informado	Confirmación registrada
envía notificación	Sistema hospitalario	Paciente	Recordatorio de cita	Sistema de notificaciones	Mensajería (SMS / correo / app)	Plataforma digital del hospital	Antes de la fecha de la cita	Mantener informado al paciente	Reducir ausencias y retrasos	Notificación enviada correctamente

Estructura de proceso

Construcción de estructura del proceso

- Actores
- Procesos principales
- Subprocesos
- Relaciones entre procesos (include - extend)



Relaciones de dominio

Identificación de las entidades principales del negocio/ Establecer relaciones.

- Entidad n
- Relación
- Multiplicidad

[illegible]

Reglas del negocio

Identificación de reglas (5 mínimo) que regulen el funcionamiento del proceso, mencionando en medio.

- La restricción o condición que debe cumplirse.
- Las entidades o actores involucrados.
- El propósito de la regla dentro del negocio.

Validación de Transacción

Nombre: Tomás Castaño, Juan David Cardozo, Camilo Ruiz

Formulario : Atención a Urgencias

Reglas de negocios

- RN-001 Aplicación Obligatoria del Triage
- RN-002 Preparación fundamental de la ambulancia
- RN-003 Reglamentación de Higiene
- RN-004 Prohibición de negar atención por falta de pago
- RN-005 Garantía de seguridad en el traslado

Regla de Negocio

Nombre: Tomás Castaño, Juan David Cardozo, Camilo Ruiz

Procesos involucrados en la regla: Documentación del caso

Código y Nombre de la regla:
«ej: Regla 01»

Descripción de la regla:
«ej: La regla garantiza la optimización de los recursos del estado»

El problema que resuelve:
«ej: Un registro escolar debe ser concedido solamente a estudiantes que no estén registrados en la actualidad para este periodo activo. Un estudiante podría registrarse en un solo colegio (para no quedarse sin cupo) mientras busca un colegio que ofrezca mejores condiciones para él»

RN-001 Aplicación Obligatoria del Triage

Realización obligatoria del informe del estado actual del paciente, se determina de forma eficiente el nivel de urgencia en el que el paciente debe ser atendido por medio de un análisis exhaustivo con un equipo médico capacitado y especializado a través de colores.

- Inconvenientes en el tratamiento del paciente
- Mala gestión de los recursos
- Análisis erróneo de prioridades en el paciente

Entidad a proteger con la regla:
«ej: Registro estudiantil»

Paciente

Estado Inicial de la Entidad:
«ej: no aprobado»

Sin clasificar

Estado Final de la Entidad si se aprueba la regla:
«ej: aprobado»

Clasificado / Determinístico

Entidades Participantes:	Entidad 1 «ej: Estudiante»	Entidad 2 «ej: Colegio»	Entidad 3 «ej: Curso»	Entidad 4 «ej: Periodo»	Entidad 5 «ej: Periodo»
	Paciente	Auxiliares medicos	Ambulancia	Enfermeros y Médicos	Secretaria
Estado Entidades Participantes: «ej: Es el estado que deben tener las entidades para que la regla se apruebe»	Estado 1 «ej: Activo y no registrado» Clasificado	Estado 2 «ej: en Funcionamiento» Capacitados	Estado 3 «ej: Con Cupo» Activa Operativa	Estado 4 «ej: Registrado» Capacitados	Estado 5 «ej: Registrado» Disponible

Regla de Negocio

Procesos involucrados en la regla:

Mantenimiento frecuente del equipo médico.

Nombre: Tomás Castaño, Juan David Cardozo, Camilo Ruiz

Código y Nombre de la regla:

«ej: Regla 01»

Descripción de la regla:

«ej: La regla garantiza la optimización de los recursos del estado»

El problema que resuelve:

«ej: Un registro escolar debe ser concedido solamente a estudiantes que no estén registrados en la actualidad para este periodo activo. Un estudiante podrá registrarse en un solo colegio (para no quedarse sin cupo) mientras busca un colegio que ofrezca mejores condiciones para él»

RN-002 Preparación fundamental de la ambulancia

Preparación del vehículo hospitalario para su uso más próximo en caso de emergencias, en pos de atender situaciones emergentes de la forma más eficiente y efectiva posible.

- Inconvenientes en su uso operativo
- Fallas técnicas durante el transporte
- Evitar negligencia médica

Entidad a proteger con la regla:

«ej: Registro estudiantil»

Entidades Participantes:

Estado Entidades Participantes:

«ej: Es el estado que deben tener las entidades para que la regla se apruebe»

Ambulancia

Estado Inicial de la Entidad:

«ej: no aprobada»

Estado Final de la Entidad si se aprueba la regla:

«ej: aprobada»

Preparación acertada

Entidad 1 «ej: Estudiante»

Entidad 2 «ej: Colegio»

Entidad 3 «ej: Curso»

Entidad 4 «ej: Período»

Entidad 5 «ej: Período»

Ambulancia

Mecánico

Equipo medico

Conductor

Enfermeros

Estado 1 «ej: Activo y no registrado»

Estado 2 «ej: en Funcionamiento»

Estado 3 «ej: Con Cupo»

Estado 4 «ej: Registrado»

Estado 5 «ej: Registrado»

Operativa. Con cupo

Capacitado Disponible

Capacitado Disponible

Capacitado Disponible

Capacitado Disponible

Regla de Negocio

Procesos involucrados en la regla:

Comunicación con otras entidades hospitalarias

Nombre: Tomás Castaño, Juan David Cardozo, Camilo Ruiz

Código y Nombre de la regla:

«ej: Regla 01»

Descripción de la regla:

«ej: La regla garantiza la optimización de los recursos del estado»

El problema que resuelve:

«ej: Un registro escolar debe ser concedido solamente a estudiantes que no estén registrados en la actualidad para este periodo activo. Un estudiante podrá registrarse en un solo colegio (para no quedarse sin cupo) mientras busca un colegio que ofrezca mejores condiciones para él»

RN-003 Reglamentación de Higiene

Seguimiento adecuado de los protocolos de seguridad e higiene médicos para el correcto tratamiento de pacientes y espacios médicos.

- Evitar negligencia médica
- Evitar posibles infecciones y contagios
- Evitar el mal tratamiento del paciente o del equipo médico.

Entidad a proteger con la regla:

«ej: Registro estudiantil»

Entidades Participantes:

Estado Entidades Participantes:

«ej: Es el estado que deben tener las entidades para que la regla se apruebe»

Salubridad del espacio hospitalario público.

Estado Inicial de la Entidad:

«ej: no aprobada»

Estado Final de la Entidad si se aprueba la regla:

«ej: aprobada»

Limpio Espacio confiable

Entidad 1 «ej: Estudiante»

Entidad 2 «ej: Colegio»

Entidad 3 «ej: Curso»

Entidad 4 «ej: Período»

Entidad 5 «ej: Período»

Personal de limpieza

Inspectores

Médicos

Recepcionistas

Pacientes

Estado 1 «ej: Activo y no registrado»

Estado 2 «ej: en Funcionamiento»

Estado 3 «ej: Con Cupo»

Estado 4 «ej: Registrado»

Estado 5 «ej: Registrado»

Disponible Capacitado

Presente Capacitado

Autorizado

Autorizados

Protegidos

Proyecto Final | Entrega 1

Regla de Negocio		Procesos involucrados en la regla:			
Nombre: Tomás Castaño, Juan David Cardozo, Camilo Ruiz		Atención al paciente sin importar el estatus económico			
Código y Nombre de la regla:	RN-004 Prohibición de negar atención por falta de pago				
Descripción de la regla:	Impedimento del centro de salud de exigir dinero al atender una urgencia médica, ya que la prioridad es el estado y la atención al paciente				
El problema que resuelve:	- Evitar negligencia médica - Paciente herido - Evitar demanda - Ineficiencia en tiempos de respuesta				
Entidad a proteger con la regla:	Paciente	Estado Inicial de la Entidad:	Individuo ingresa al servicio de urgencias	Estado Final de la Entidad si se aprueba la regla:	Paciente atendido satisfactoriamente y cobro a la aseguradora o Estado
Entidades Participantes:	Entidad 1 -ej: Estudiante- Personal Médico	Entidad 2 -ej: Colegio- Enfermeros	Entidad 3 -ej: Curso- Paciente	Entidad 4 -ej: Período- Defensoría del pueblo	Entidad 5 -ej: Período- Aseguradora o Estado
Estado Entidades Participantes:	Estado 1 -ej: Activo y no registrado- Disponible Capacitado	Estado 2 -ej: en Funcionamiento- Presente Capacitado	Estado 3 -ej: Con Cupo- Atendido, en buen estado	Estado 4 -ej: Registrado- Autorizados y activos capacitados	Estado 5 -ej: Registrado- Autorizados y activos capacitados

Regla de Negocio		Procesos involucrados en la regla:			
Nombre: Tomás Castaño, Juan David Cardozo, Camilo Ruiz		Verificar todos los requerimientos de seguridad y atención para el traslado			
Código y Nombre de la regla:	RN-005 Garantía de seguridad en el traslado				
Descripción de la regla:	Tomar las medidas y requerimientos adecuados para trasladar al paciente al centro médico más cercano, cumpliendo con el estado de bienestar pertinente y la integridad de todos los presentes en la ambulancia				
El problema que resuelve:	- Evitar negligencia médica - Evitar accidentes y perjudicaciones técnicas - Evitar que el paciente y personal médico se vea afectado en su integridad física y mental - Evitar desprotección jurídica y clínica - Inadecuación del recurso, se espera llevar un transporte adecuado				
Entidad a proteger con la regla:	Paciente	Estado Inicial de la Entidad:	Estado vulnerable o crítico	Estado Final de la Entidad si se aprueba la regla:	Paciente trasladado
Entidades Participantes:	Entidad 1 -ej: Estudiante- Paciente	Entidad 2 -ej: Colegio- Auxiliares médicos	Entidad 3 -ej: Curso- Enfermeros	Entidad 4 -ej: Período- Conductor/piloto	Entidad 5 -ej: Período- Centro regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE)
Estado Entidades Participantes:	Estado 1 -ej: Activo y no registrado- Vulnerable	Estado 2 -ej: en Funcionamiento- Presente Capacitado	Estado 3 -ej: Con Cupo- Presente Capacitado	Estado 4 -ej: Registrado- Presente Capacitado	Estado 5 -ej: Registrado- Capacitados y autorizados

Stakeholders

Identificación de stakeholders (mínimo 5) que se relacionan con el sistema.

Stakeholder	Rol	Actividad
Hospital	Entidad representativa	Manejo general del sistema y la información.
Médico	Gestor del sistema	Consulta y gestión de la información
Paciente	Cliente	Solicitar servicio
Enfermero	Gestor del sistema	Hacer seguimiento de la información.
Recepcionista	Consultor del sistema	Consultar la información
Auxiliar médico	Soporte operativo	Registro del triaje

Perfil Stakeholders

Unid. Organizacional: Atención de Urgencias

Nombre:

Alcance: Atención de emergencias

Representante
«[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]»

Hospital

Descripción
«[Breve descripción del tipo de actor.]»

Elemento fundamental que relaciona los demás elementos entre sí (paciente, médicos, enfermeros, ambulancias); sin él no puede existir una entidad unificada médica que atienda urgencias.

Tipo
«[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas.]»

Interno

Responsabilidades
«[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interés como parte interesada.]»

Atención de cualquier tipo de emergencia médica.

Criterios de Éxito
«[¿Cómo define el actor el éxito? ¿Cómo se recompensa el interesado?]

Proporción de un servicio satisfactorio

Intervención
«[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]»

Principal entidad de atención de siniestros o urgencias

Entregables
«[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]»

Informe técnico de la emergencia atendida

Comentarios y problemas
«[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]»

Falta del material necesario para la atención de urgencias.

Stakeholder: Hospital

Proyecto Final | Entrega 1

Perfil Stakeholders		Unid. Organizacional:
Nombre:	Alcance:	
Representante «[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]»	Médico	
Descripción «[Breve descripción del tipo de actor.]»	Encargado de mantener la estabilidad del paciente, brindando una atención pertinente al paciente	
Tipo «[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas.]»	Interno	
Responsabilidades «[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interés como parte interesada.]»	Encargado de atender una urgencia médica de manera más especializada y enfocada a una atención más óptima según un diagnóstico previamente realizado	
Criterios de Éxito «[¿Cómo define el actor el éxito? ¿Cómo se recompensa el interesado?]	Una atención al paciente hecha de manera pertinente que permita ampliar su historial médico y reputación en la entidad hospitalaria	
Intervención «[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]»	Se relaciona con las demás entidades del hospital de forma directa, realizando un intercambio de información relacionada al paciente que va a ser atendido para determinar la atención que se requiere. Además de proporcionarle soporte de gestión al recepcionista	
Entregables «[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]»	Una atención correcta hacia el paciente donde su estado que encuentre en el mejor estado posible y que además se le brinde el tratamiento adecuado. Gestionado en un informe	
Comentarios y problemas «[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]»	Le de una emergencia o complicaciones médicas al doctor que puedan afectar al rendimiento de su atención al paciente	

Stakeholder: Médico

Perfil Stakeholders		Unid. Organizacional:
Nombre:	Alcance:	
Representante «[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]»	Paciente	
Descripción «[Breve descripción del tipo de actor.]»	Quien da inicio al servicio del sistema, causa o motivo principal de la realización del proceso de atención de urgencias.	
Tipo «[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas.]»	Externo	
Responsabilidades «[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interés como parte interesada.]»	Cooperación con el personal médico para el acertado abordaje de la situación emergente.	
Criterios de Éxito «[¿Cómo define el actor el éxito? ¿Cómo se recompensa el interesado?]	Atención hospitalaria recibida, estabilidad personal del paciente otorgada de manera asertiva.	
Intervención «[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]»	Principal motivo de la existencia del proceso y el funcionamiento del mismo.	
Entregables «[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]»	Experiencia, capital, información personal.	
Comentarios y problemas «[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]»	Poca cooperación por parte del paciente o de allegados al mismo.	

Stakeholder: Paciente

Perfil Stakeholders		Unid. Organizacional:
Nombre:		Alcance:
Representante «[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]»	Enfermeros	
Descripción «[Breve descripción del tipo de actor.]»	Personal encargado de dar apoyo a los médicos de cabecera en caso de siniestros; su función se evidencia al brindar a los pacientes la atención básica antes de ser remitidos con un médico general.	
Tipo «[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas.]»	Interno	
Responsabilidades «[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interés como parte interesada.]»	Apoyo de pacientes y médicos en caso de urgencias para facilitar el tratamiento al paciente.	
Criterios de Éxito «[¿Cómo define el actor el éxito? ¿Cómo se recompensa el interesado?]	Urgencia atendida con normalidad.	
Intervención «[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]»	Equipo de apoyo médico	
Entregables «[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]»	Suministros médicos, conocimiento del siniestro.	
Comentarios y problemas «[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]»	Poca capacitación del personal de enfermería.	

Stakeholders: Enfermos

Perfil Stakeholders		Unid. Organizacional:
Nombre:		Alcance:
Representante «[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]»	Recepcionista	
Descripción «[Breve descripción del tipo de actor.]»	Ente encargado de la gestión de consultas al sistema en casos emergentes o de urgencias.	
Tipo «[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas.]»	Interno	
Responsabilidades «[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interés como parte interesada.]»	Principal encargado de la toma de información en casos de urgencias y de la asignación apropiada de los suministros hospitalarios. Consultor del sistema para el monitoreo de información.	
Criterios de Éxito «[¿Cómo define el actor el éxito? ¿Cómo se recompensa el interesado?]	Recepción adecuada de la información referente a un caso de urgencia médica.	
Intervención «[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]»	Permite la acertada comunicación entre el paciente y el hospital (junto a los elementos internos como médicos, enfermeros, auxiliares hospitalarios).	
Entregables «[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]»	Información referente al caso de siniestro (ubicación, situación actual, número de afectados...).	
Comentarios y problemas «[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]»	Errónea interpretación de la información suministrada.	

Stakeholder: Recepcionista

Perfil Stakeholders		Unid. Organizacional:
Nombre:	Alcance:	
Representante «[Quién es el representante de las partes interesadas del proyecto? (Esto es opcional, si está documentado en otro lugar.) Lo que queremos aquí son nombres.]»	Auxiliares Médicos	
Descripción «[Breve descripción del tipo de actor.]»	Son personas capacitadas en manejar recursos y suplementos médicos, además de tener habilidades y conocimiento de gestión médica	
Tipo «[Califique la experiencia y los antecedentes de las partes interesadas.]»	Interna	
Responsabilidades «[Enumere las responsabilidades clave de la parte interesada con respecto a los cambios que se están realizando, es decir, su interés como parte interesada.]»	Se encargan principalmente de dar soporte, atención técnica y de higiene, manejar logística, y brindar apoyo a los enfermeros y demás entidades del hospital, asegurándose de que todo salga en orden con los requerimientos adecuados	
Criterios de Éxito «[¿Cómo define el actor el éxito? ¿Cómo se recompensa el interesado?]	Una correcta gestión y soporte brindado a las entidades médicas que permitan una mejor reputación y visión hacia el hospital, proporcionándoles un posible aumento	
Intervención «[¿Cómo participa la parte interesada en el proyecto? Relacionarse, cuando sea posible, con los roles de Rational Unified Process, es decir, Revisor de modelos de casos de uso empresarial, etc.]»	Es la persona más relacionada al resto de actores del sistema, brindando soporte y atención en requerimientos tanto a cualquier entidad del hospital como al paciente a ser atendido	
Entregables «[¿Hay entregables adicionales requeridos por las partes interesadas? Estos podrían ser entregables del proyecto o resultados del sistema en desarrollo.]»	Un informe adecuado donde se proyecte el soporte	
Comentarios y problemas «[Los problemas que interfieren con el éxito y cualquier otra información relevante van aquí.]»		

Stakeholder: Auxiliares médicos

Investigación complementaria

Realización autónoma de conceptos adicionales que complementen el análisis del negocio.

- Identificación de variables o factores que afectan al negocio

Variables y factores que afectan la atención a urgencias:

Los factores que perjudican directamente la atención de emergencias son la saturación del servicio, escasez de personal, esperas tardías y falta de comunicación, todo esto hace que la atención a urgencias se vea afectada de manera drástica tanto hacia los pacientes y a la entidad hospitalaria. Otros factores pueden llegar a ser la gravedad del paciente y uso inadecuado del servicio para casos no urgentes.

Variables organizacionales y de recursos

- **Sobrecarga de pacientes:** Al tener un alto volumen de personas que atender, esto hace que el flujo de la atención hacia los pacientes sea menos eficiente y pueda conllevar a contratiempos o malentendidos inesperados.
- **Escasez de personal:** Falta de médicos y enfermeras, lo que incrementa la sobrecarga laboral y el estrés, disminuyendo la calidad asistencial. Además de fatiga excesiva y sobreexplotación a personal anteriormente contratado.

- **Gestión del Triage:** Fallas en el proceso de clasificación de riesgo. Lo que generaría un riesgo muy perjudicial y falta de prioridad hacia el paciente, brindando de esta manera una atención inadecuada.
- **Recursos limitados:** Limitaciones en infraestructura y personal. Además de suministros faltantes y escasos lo que afectará drásticamente a la atención pertinente al paciente, sobre todo a su tratamiento

Variables relacionadas al paciente:

- **Uso no pertinente:** Asistencia por patologías no urgentes que saturan el servicio. Da un mal diagnóstico.
- **Nivel socioeconómico y cultural:** Barreras en la comunicación, miedo o incomprensión de las normas.
- **Gravedad de la urgencia:** Condiciona tiempos de atención y resultados, generando una inconformidad en el paciente

Variables relacionadas al personal de salud:

- **Estrés y fatiga:** El agotamiento del personal (burnout) afecta la atención.
- **Comunicación:** Actitudes desobligantes o mala relación médico-paciente.
- **Experiencia:** Diferencias en los tiempos de decisión entre médicos residentes y adscritos (especialistas).

Variables del Entorno y Sistema:

- **Tiempo y accesibilidad:** Largas esperas que generan insatisfacción.
- **Factores externos:** Políticas, normativas o presiones económicas.